UNIDADE DE PNEUMOLOGIA E ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA — PRONTUÁRIO MÉDICO ELETRÔNICO (DOC-MED-003)

Laudo Clínico e Funcional Respiratório: Asma Brônquica Alérgica Persistente Moderada

ID Prontuário:	**DOC-MED-003**	**Paciente:**	**P-03 (Lucas Gabriel Oliveira)**	**Idade / Sexo:**	7 anos | Masculino (Paciente Pediátrico)
Antropometria:	24,5 kg | 1,22 m	**Data/Hora:**	11/11/2026 - 14:20h	**Código CID-10:**	**J45.0 (Asma predominantemente alérgica)**

Mapeamento Semântico e Resolução de Entidades (KAG Ontologia): Diagnóstico Canônico: Asma Brônquica Alérgica (Aliases: Bronquite Asmática, Asma Alérgica, Hiperreatividade Brônquica). Causas: Alérgenos Domésticos (Aliases: Ácaros, Dermatophagoides pteronyssinus). Fármacos: Salbutamol (Aliases: Aerolin), Budesonida, Propranolol (Contraindicado).

1. ANAMNESE, HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL (HDA) E ANTECEDENTES

Paciente pediátrico masculino, 7 anos de idade, estudante do ensino fundamental, trazido pelos pais ao serviço de pneumologia pediátrica com histórico de crises recorrentes de dispneia, aperto torácico, tosse seca irritativa predominantemente noturna e ao despertar, além de chiado audível no peito (sibilância) desencadeado por exercícios físicos escolares, mudanças bruscas de temperatura e contato com poeira domiciliar.

A mãe relata que a criança apresentou três visitas ao pronto-socorro nos últimos 6 meses necessitando de nebulização de resgate, além de apresentar rinite alérgica concomitante e dermatite atópica na primeira infância (marcha atópica).

2. EXAME FÍSICO DIRECIONADO E PROPEDÊUTICA COMPLEMENTAR

Parâmetro Clínico / Exame de Imagem	Achados Objetivos e Descrição Propedêutica
Sinais Vitais Pediátricos	FC: 112 bpm | FR: 28 irpm | SpO2: 94% em ar ambiente | Temp: 36,5 °C | Pico de Fluxo Expiratório (PFE): 68% do predito
Inspeção Respiratória	Tiragem intercostal leve bilateral, tempo expiratório prolongado, sem cianose central.
Ausculta Pulmonar	Murmúrio vesicular globalmente distribuído com presença de sibilos expiratórios difusos e polifônicos em ambos os hemitórax.
Espirometria com Prova Broncodilatadora	Padrão ventilatório obstrutivo moderado (VEF1 = 69% do previsto; relação VEF1/CVF = 0,71). Após administração de 400 mcg de Salbutamol inalatório, observou-se incremento de +18% e +260 mL no VEF1, comprovando reversibilidade e hiperreatividade brônquica.

3. PAINEL DE BIOMARCADORES E EXAMES LABORATORIAIS

Exame / Biomarcador Analisado	Resultado Obtido no Paciente	Valor de Referência / Interpretação
IgE Sérico Total	**685 UI/mL**	< 90 UI/mL para a faixa etária (Elevado)
IgE Específica (Dermatophagoides pteronyssinus)	**42,5 kUA/L (Classe 4 - Muito Alto)**	< 0,35 kUA/L
Eosinófilos no Sangue Periférico	**740 células/µL (9,2%)**	< 350 células/µL (Eosinofilia Alérgica)
Fração Exalada de Óxido Nítrico (FeNO)	**46 ppb**	< 20 ppb em crianças (Inflamação Eosinofílica)
Radiografia de Tórax PA/Perfil	**Hiperinsuflação pulmonar discreta**	Ausência de consolidações pneumônicas
Teste Cutâneo de Leitura Imediata (Prick Test)	**Pápula de 8 mm para Ácaros Domésticos**	Controle histamina positivo (5 mm)

4. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO E FISIOPATOLOGIA / ETIOLOGIA (CAUSAS)

A Asma Brônquica Alérgica (Bronquite Asmática) é mediada por uma resposta imunológica Th2 exacerbada frente à exposição inalatória contínua a Alérgenos Domésticos (Ácaros da poeira domiciliar — Dermatophagoides pteronyssinus)

somada à Predisposição Genética Atópica. A degranulação de mastócitos mediada por IgE e a infiltração eosinofílica promovem edema da mucosa brônquica, hipersecreção de muco e contração da musculatura lisa bronquiolar.

5. PLANO TERAPÊUTICO, PRESCRIÇÃO FARMACOLÓGICA E CONDUTA CLÍNICA

1. Terapia de Alívio Imediato (Resgate de Crise): Prescrição de agonista seletivo dos receptores beta-2 adrenérgicos de curta duração (SABA) Salbutamol (Aerolin) spray 100 mcg/jato — 2 a 4 jatos com espaçador valvulado a cada 20 minutos na fase aguda e se necessário para alívio de broncoespasmo.

2. Terapia Controladora de Manutenção Diária: Corticosteroide inalatório Budesonida 200 mcg inalado de 12/12h continuamente para supressão da inflamação eosinofílica da via aérea.

3. Controle Ambiental Estrito: Encapamento impermeável de colchões e travesseiros, remoção de tapetes/cortinas para redução da carga de Alérgenos Domésticos (Ácaros).

[ALERTA DE GRAFO KAG - SEGURANÇA FARMACOLÓGICA E BLOQUEIO RECEPTOR]:

• Contraindicação Absoluta ao Propranolol (Conexão Direta com DOC-MED-006): Pacientes diagnosticados com Asma Brônquica Alérgica (Bronquite Asmática) possuem contraindicação absoluta ao uso de betabloqueadores não-seletivos, especificamente o Propranolol (amplamente prescrito na profilaxia da Enxaqueca Crônica com Aura no DOC-MED-006). O Propranolol bloqueia competitivamente os receptores adrenérgicos Beta-2 da musculatura lisa brônquica, antagonizando diretamente o efeito broncodilatador do Salbutamol (Aerolin) e desencadeando Broncoespasmo Severo potencialmente fatal.

Autenticação Digital: Junta Médica de Suporte à Decisão Clínica (GraphRAG & KAG Healthcare) | Registro DOC-MED-003 — Validação Completa.